

				☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS					
Lincon Ricardo Moraes Nepomuceno					
IDADE: 69	PESO: 139	ALTURA: 175	PROFISSÃO: Comerciante		
SINTOMAS: Refluxo gastr. / mms edem. / Marcevaria					
QUEIXAS: Acordar variadas / acordar cedo / Boca seca					
MEDICAMENTOS: Flavonid / Aneprozol / Rivaroxabana / Concor					
Enalapril / Simvastatina / glicafag / gliclazido / Espiro-lactona					
MÉDICO: Dr. Renato Rios Côrrea					
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N					
EXERCÍCIO FÍSICO: 2x Pilates					
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: ☒ JANTAR: S (18:30)					
HORA QUE DORME: 21:30		HORA QUE ACORDA: 5hr.			
COCHILHO ☒ SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL			
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO		X NA SEMANA ☒ NÃO Ronca (esposa)			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:					
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 4x					
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gordinha			CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:		
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH:	SPO2:		
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Arterio. crônica / D.M / Gordura no					
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA CI CPAP: 12.8.21w fígado					
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Provavel IMC: 41.					
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA					
(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS					
03/09 Avaliação					
24					
10/09/24 P= 7.8 cmH ₂ O Ajustou masc.					
IAH= 5.2 e lev					
m. de uso: 6hr Guar.					
não estava utilizando					
07/01 Mandar um fixador p/ Dream Wear					
25 Guar.					

Dr. Renato Rios Corrêa

CARDIOLOGIA CLINICA
CRM 72962

Eletrocardiograma
Ecocardiograma com Doppler
Holter Ritmo e Pressão
Teste de Esforço

Dr. Lincoln Rios M. Nepomuceno

Soluto:

Polissonografia e
ajuste CPAP

02.02.2014

Dr. Renato Rios Corrêa
CRM 72962

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LINCON RICARDO MOARES NEPOMUCENO-CPAP			
Sexo: M	Idade: 62 anos	Peso: 130 Kg	Altura: 1,80 m
IMC: 40,1	Data do Exame: 18/01/2018	Exame: 31609_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:26:19 horas e encerrado às 05:43:47 horas, com latência para o sono de 41 minutos e latência para o sono REM de 349 minutos. O tempo total de sono foi de 234,5 minutos, com eficiência do sono de 53,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	5,8%	Até 5%
Estágio 2	45,4%	45 - 55%
Estágio 3	37,3%	> 15%
Sono REM	11,5%	20 - 25%
Eficiência do sono	53,6%	> 85%

No período total de sono permaneceu 203,0 minutos acordado e ocorreram 42 micro despertares (índice de 10,7/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 71 bpm, a maior de 81 bpm e a menor de 60 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 47 eventos respiratórios, sendo 0 central, 47 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 12,9/hora, sendo 0,3 apnéia/hora e 11,8 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 31,1/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 31,1 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 97% e a mínima de 85%, permanecendo 1,7 minutos (0,4%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 49 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
 - 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
 - 3 - Registro de ronco.
 - 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
 - 5 - Eficiência do sono reduzida.
- PSG com CPAP, P95% = 12,4cmH2O.

Guilherme Salomon De Dominicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LINCOLN RICARDO MORAES NEPOMUCENO			
Sexo: M	Idade: 61 anos	Peso: 130 Kg	Altura: 1,80 m
IMC: 40,1	Data do Exame: 22/06/2016	Exame: 11139_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:23:59 horas e encerrado às 05:57:40 horas, com latência para o sono de 6 minutos e latência para o sono REM de 290 minutos. O tempo total de sono foi de 366,0 minutos, com eficiência do sono de 71,3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista
Estágio 1	2,7%	Até 5%
Estágio 2	69,1%	45 - 55%
Estágio 3	11,7%	> 15%
Sono REM	16,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	71,3%	> 85%

No período total de sono permaneceu 147,5 minutos acordado e ocorreram 87 micro despertares (índice de 14,3 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 61 bpm, a maior de 86 bpm e a menor de 51 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 153 eventos respiratórios, sendo 0 central, 158 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 25,9/hora, sendo 13,9 apnéia/hora e 12,0 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 29,0/hora, sendo 4,0 apnéia/hora e 25,0 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 97% e a mínima de 82%, permanecendo 12,0 minutos (2,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 127 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Paciente com Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado, sendo todos os eventos do tipo obstrutivo (normal até 5/hora).
- 2 - Presença de dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- Eficiência do sono diminuída devido ao tempo total desperto durante o exame (normal 85%).
- Porcentagem diminuída do sono de ondas lentas e do sono REM.

José Aristóbulo de Almeida Capelli
CRM-SP 104110